Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Причины 3

2.3 Классификация 3

2.4 Шкала Lund — Kennedy 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы 5

3.2 Осмотр 5

3.3 Лучевая диагностика 5

3.4 Лабораторные исследования 5

3.5 Консультации и другие исследования 6

4. Лечение 6

4.1 Кортикостероиды 6

4.2 Другие препараты 6

4.3 Генно-инженерная биологическая терапия 6

4.4 Дозы 7

4.5 Хирургическое лечение 7

4.6 Реабилитация 8

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 8

5.1 Госпитализация 8

6. Источник и актуальность **9**

6.1 Неточности в самом тексте КР 9

1. Главное

- Диагноз ставят по жалобам, анамнезу, осмотру и инструментальным данным: передней риноскопии, эндоскопии полости носа и носоглотки и КТ околоносовых пазух.
- Препарат выбора — мометазон в виде назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки курсом 3–6 месяцев. Если за 5–6 недель симптомы не уменьшились, обсуждают операцию.
- Системные антибиотики при полипозном риносинусите не рекомендуются.
- При тяжёлом течении, а также при сочетании с бронхиальной астмой рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия: дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.
- Если лекарства не помогают или полипоз распространённый, показана операция, оптимально — функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В первый год после операции пациента осматривают каждые 3 месяца.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС) — фенотип хронического риносинусита. Это неоднородное по причинам и механизмам хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП), которое длится больше 12 недель и сопровождается её ремоделированием, образованием и повторным ростом полипов.

Полипы носа — доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС — воспаление с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным общим IgE. К нему относят эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральную компартментную атопическую болезнь (CCAD) — изолированные полипозные изменения слизистой верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки у пациентов с установленной аллергией на ингаляционные аллергены.

2.2 Причины

В развитии ПРС участвуют нарушения врождённого и адаптивного иммунитета, аллергия, генетически обусловленные болезни (иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия), изменения внутриносовой анатомии и инфекция — бактериальная, грибковая, вирусная. Вместе или по отдельности они поддерживают хроническое воспаление слизистой носа, которое ведёт к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом чаще всего встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже — парадоксальный изгиб средней раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единой классификации нет. Клинически и эндоскопически различают три стадии: в первой полипы ограничены средним носовым ходом, во второй выходят за его пределы, в третьей обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки используют шкалу Lund — Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оценивают отдельно справа и слева, каждый признак — от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund — Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипов нет	Полипы в среднем носовом ходе	Полипы выходят за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёка нет	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемого нет	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Данные КТ оценивают по шкале Lund — Mackay: снижение пневматизации каждой пазухи справа и слева отдельно оценивают в 0 баллов, если изменений нет, в 1 балл при частичном затенении и в 2 балла при тотальном. Остиомеатальный комплекс оценивают в 0 баллов, если он интактен, и в 2 балла, если он обтурирован. Сумма для каждой стороны — от 0 до 12 баллов, всего — от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund — Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости записаны в ней дважды, а задних клеток решётчатой кости нет. Остиомеатальному комплексу в таблице дана оценка 0, 1 или 2 балла, а в тексте — только 0 или 2. В строке «Общее количество баллов» справа стоят 0, 7 и 14, слева — 0, 1 и 2, хотя ключ под таблицей говорит о сумме от 0 до 12 на сторону. Считайте по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Пациентов беспокоят заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки, тяжесть и давление в области носа и проекции пазух, диффузная головная боль, снижение или потеря обоняния. Иногда к этому присоединяются жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость, недомогание, снижение работоспособности и сонливость. Важно оценить, насколько выражены симптомы и как долго они длятся. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Жалобы полезно разделить на группы. Назальные — затруднённое носовое дыхание, выделения, ухудшение или отсутствие обоняния. Болевые — лицевая боль, ощущение полноты и давления в лице, головная и зубная боль. Оро- и назофарингеальные — неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах. Системные — недомогание, утомляемость, снижение работоспособности. Такое разделение помогает подтвердить диагноз, оценить тяжесть и найти факторы, влияющие на выбор лечения.

Выясняют, когда и из-за чего появились симптомы, в какой последовательности, насколько они выражены и как менялись, что на них влияет, какие обследования уже проводились и как пациента лечили. Отдельно уточняют связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами, непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов, симптомы бронхиальной астмы, ПРС у близких родственников, одно- или двустороннюю локализацию симптомов и повторяющиеся носовые кровотечения.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по жалобам, анамнезу, данным физикального и инструментального обследования: передней риноскопии, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки, КТ околоносовых пазух.

3.1 Жалобы

У всех пациентов с подозрением на ПРС и с установленным диагнозом уточняют, есть ли две жалобы или больше, причём одна из них — заложенность носа или выделения из носа; учитывают также боль и давление в проекции пазух, снижение или потерю обоняния. Это нужно, чтобы подтвердить диагноз и оценить тяжесть.

Тяжесть заболевания у всех пациентов оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент ставит оценку от 0 (симптома нет) до 10 баллов (симптом выражен максимально). Лёгкому течению соответствуют 0–3 балла, умеренному — 3–7, тяжёлому — 7–10. Заметно ухудшают качество жизни симптомы на 5 баллов и выше.
Диагностическая специфичность выше, если два или больше субъективных симптома сочетаются с объективными признаками — данными эндоскопии носа и лучевой визуализации.

> В комментарии к рекомендации сказано, что оценка жалоб даёт много ложноположительных заключений, но тут же приведены специфичность 89% и чувствительность 2%. Высокая специфичность означает как раз мало ложноположительных результатов, так что цифры, по-видимому, переставлены местами.

> Границы степеней тяжести по ВАШ в КР перекрываются: 0–3, 3–7 и 7–10 баллов. Куда относить 3 и 7 баллов, не сказано.

3.2 Осмотр

Каждого пациента с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом осматривает оториноларинголог, чтобы поставить диагноз и оценить особенности течения.

Важны пальпация и перкуссия в проекции пазух, признаки назальной обструкции (затруднённое дыхание, гнусавость), вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое и сами полипы. При долгом течении и распространённом процессе полипы бывают видны уже в преддверии носа, а иногда расширяется спинка наружного носа.

Всем пациентам проводят переднюю риноскопию, чтобы оценить распространённость процесса и сопутствующую внутриносовую патологию.

Всем пациентам выполняют эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки, чтобы определить локализацию и распространённость изменений слизистой.

Эндоскопия позволяет отличить ПРС от болезней со сходными симптомами — опухолей, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин. Вместе с жалобами и анамнезом она заметно повышает точность диагноза: специфичность и чувствительность метода — 84% и 66%.

3.3 Лучевая диагностика

Всем пациентам выполняют КТ околоносовых пазух, чтобы оценить распространённость полипоза, внутриносовые структуры и костные стенки пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ можно делать конусно-лучевую томографию носа и пазух: лучевая нагрузка ниже, и годовая доза на одну анатомическую зону не превышается.

При подозрении на новообразование носа и пазух в дополнение к КТ проводят МРТ околоносовых пазух.

Обычная рентгенография пазух дешевле и доступнее, но при ПРС она мало информативна по сравнению с КТ.

3.4 Лабораторные исследования

У всех пациентов операционный материал направляют на патолого-анатомическое исследование, чтобы различить субтипы полипозного риносинусита.

Всем пациентам делают цитологическое исследование отделяемого, отпечатков и мазков со слизистой верхних дыхательных путей, чтобы выявить аллергическое воспаление и выбрать тактику лечения.

О выраженном аллергическом компоненте говорят эозинофилы больше 10% в поле зрения.

3.5 Консультации и другие исследования

При подозрении на бронхиальную астму или атопию пациента консультирует пульмонолог и (или) аллерголог-иммунолог, чтобы уточнить диагноз и согласовать лечение.

При подозрении на первичную цилиарную дискинезию исследуют скорость мукоцилиарного транспорта сахариновым тестом.

---

4. Лечение

Лекарственное и хирургическое лечение улучшают качество жизни при ПРС значительно и почти одинаково, поэтому адекватная лекарственная терапия стоит на первом месте.

4.1 Кортикостероиды

Кортикостероиды в виде назальных спреев назначают как стартовую терапию при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также до и после операции.

Предпочтительны препараты с высокой топической активностью и низкой биодоступностью: они безопаснее при длительном применении. Спреи уменьшают полипы, заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

Если за 5–6 недель применения мометазона симптомы не уменьшились, рассматривают хирургическое лечение.

Системные кортикостероиды назначают при гиперреактивности бронхов, бронхиальной астме, непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов, рефрактерном течении ПРС, выраженной атопии, а также для подготовки к операции и после неё, чтобы уменьшить воспаление.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

4.2 Другие препараты

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов назначают дополнительно или вместо системных кортикостероидов — при их непереносимости или при рефрактерном течении ПРС, устойчивом к кортикостероидам.

Системные антибиотики при ПРС не рекомендуются: доказательств эффективности недостаточно, а риски — резистентность микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта — реальны.

Макролиды обсуждают из-за их иммуномодулирующего и противовоспалительного действия, но оптимальный препарат, доза и длительность неизвестны, поэтому однозначного вывода об их эффективности при ПРС сделать нельзя.

4.3 Генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой назначают генно-инженерную биологическую терапию (ГИБТ) — дупилумаб, омализумаб или меполизумаб, — чтобы повысить эффективность лечения и снизить риск рецидивов.

Это рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, которые избирательно связывают IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и операциях в анамнезе, если есть три критерия из следующих: признаки Т2-воспаления (эозинофилы в ткани не меньше 10 в поле зрения, или в крови не меньше 150 клеток/мкл, или общий IgE не меньше 100 МЕ/мл); потребность в системных кортикостероидах (2 курса и больше за год или приём дольше 3 месяцев) либо противопоказания к ним; значимое снижение качества жизни (SNOT-22 не меньше 40); аносмия при оценке обоняния; бронхиальная астма, требующая регулярных ингаляционных кортикостероидов.

Ответ оценивают по пяти критериям: уменьшение полипов, меньшая потребность в системных кортикостероидах, лучшее качество жизни, улучшение обоняния и меньшее влияние сопутствующих болезней. 4–5 критериев — хороший ответ, 2–3 — умеренный, 0–1 — слабый или его нет. Эффект оценивают через 6 месяцев и через год. Если ответа нет, пересматривают диагноз, прекращают лечение и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение длительное, и при перерыве возможен рецидив. При беременности препараты применяют, только если ожидаемая польза для матери выше риска для плода. При грудном вскармливании решают, прекратить кормление или отменить препарат, с учётом пользы того и другого.

Продолжать ли терапию, врач решает по тяжести заболевания и тому, как контролируются обострения.

4.4 Дозы

Препарат	Доза
Мометазон, назальный спрей	По 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс 3–6 месяцев. После достижения эффекта — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).
Преднизолон	Коротким курсом, если назальные кортикостероиды не контролируют симптомы: 30–60 мг в сутки в таблетках 14 дней.
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. Пропущенное лечение возобновляют как можно скорее; пожилым дозу не меняют.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; дозу и частоту определяют по исходному IgE и массе тела и корректируют при значительном изменении массы.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.5 Хирургическое лечение

Операцию выполняют, если лекарственная терапия неэффективна, а также при распространённом полипозе носа и пазух, чтобы восстановить носовое дыхание.

Оптимальный вариант — функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ): удаление полипозно изменённой слизистой носа и пазух, восстановление проходимости естественных соустий и устранение анатомических нарушений — чаще всего септопластика и (или) резекция носовых раковин, а также резекция решётчатой буллы под видеоэндоскопическим контролем.

В зависимости от выраженности изменений можно ограничиться минимально инвазивными вмешательствами, которые обеспечивают дренирование и аэрацию пазух.

Всем пациентам перед операцией назначают кортикостероиды в виде назальных спреев: так меньше кровопотеря, лучше видно операционное поле и короче операция.

Результат операции во многом зависит от предоперационной лекарственной подготовки.

4.6 Реабилитация

После любой операции проводят комплексную реабилитацию, чтобы восстановить носовое дыхание и функцию слизистой носа и пазух.

Она включает охранительный режим 10–14 дней и дольше, санацию носа и пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация — аспирация» в раннем послеоперационном периоде и бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина, чтобы не образовались синехии. При избытке вязкого отделяемого или корках нос орошают 0,9% раствором натрия хлорида: так местные препараты лучше контактируют со слизистой.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациенты с ПРС находятся под диспансерным наблюдением оториноларинголога, чтобы вовремя заметить ухудшение на фоне лечения или рецидив после операции и скорректировать лечение.

Специфической профилактики нет. Если до и после операции 6–12 месяцев применять назальные кортикостероиды, у большинства пациентов воспаление уменьшается, качество жизни растёт, рецидивы реже, а ремиссия длиннее.

Кратность осмотров определяют индивидуально, но в первый год после операции пациента осматривают каждые 3 месяца. При рецидиве, требующем повторной операции, и при подозрении на осложнённое течение делают КТ пазух.

Пациентам с ПРС нужны ежедневные назальные кортикостероиды, нередко всю жизнь с небольшими перерывами.

> Длительность назальных кортикостероидов в КР указана по-разному: курс мометазона — 3–6 месяцев (раздел 3.1), до и после операции — 6–12 месяцев (раздел 5), а в разделе 7 — ежедневно, нередко всю жизнь.

Оториноларинголог наблюдает пациента систематически, не реже раза в 3 месяца. Результат зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от того, насколько пациент привержен лечению и выполняет рекомендации.

> В разделе 5 сказано, что кратность обследований решают индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца нужны в первый год после операции. В разделе 7 и в информации для пациента — наблюдение всегда не реже раза в 3 месяца.

Главная задача — комплексное лечение, которое контролирует симптомы и улучшает качество жизни. Иногда нужны повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме пациента наблюдает и аллерголог-иммунолог.

5.1 Госпитализация

Обследовать и лечить пациентов можно как амбулаторно, так и в стационаре.

Планово госпитализируют на ФЭРСХ, с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё, если нет противопоказаний к операции. Плановая госпитализация в дневной или круглосуточный стационар возможна также для подбора и коррекции терапии и для лечения генно-инженерными биологическими препаратами.

После операции выписывают при удовлетворительном общем состоянии и улучшении или восстановлении носового дыхания.

По алгоритму КР после диагностики пациента с аллергией или бронхиальной астмой направляют к аллергологу-иммунологу или пульмонологу. Если показаний к операции нет, его наблюдают и лечат амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, госпитализируют для ФЭРСХ в специализированный стационар, после чего продолжают наблюдение и лекарственное лечение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Таблица шкалы Lund — Mackay в приложении Г3 расходится с текстом раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости повторены дважды, задних клеток решётчатой кости нет, остиомеатальный комплекс оценён в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- В комментарии о жалобах заявлена высокая вероятность ложноположительных заключений, но приведены специфичность 89% и чувствительность 2% — по смыслу цифры переставлены.
- Границы степеней тяжести по ВАШ перекрываются: 0–3, 3–7 и 7–10 баллов.
- Длительность назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (3.1), 6–12 месяцев (5), ежедневно, нередко всю жизнь (7).
- Кратность наблюдения: в разделе 5 — индивидуально, каждые 3 месяца в первый год после операции; в разделе 7 — всегда не реже раза в 3 месяца.
- Назальные кортикостероиды перед операцией рекомендованы дважды с разными уровнями: в разделе 3.1 — УУР С, УДД 5, в разделе 3.2 — УУР В, УДД 2.
- В оглавлении подраздел «Физикальное обследование» пронумерован как 2.1 вместо 2.2, а приложение А3.1 стоит на странице 30, раньше приложения А3 на странице 31.